Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
10ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent10vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5026205-16.2023.8.21.0001/RS

AUTOR: MARIA OTILIA JOBIM DURAND

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

1) MARIA OTILIA JOBIM DURAND ajuizou ação em face de UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA.

Arguiu, em suma, ter sido diagnosticada com Fibrose Pulmonar Idiopática Grave (CID 10 – J84.1). Liminarmente, pugna pela autorização e disponibilização do medicamento Nintedanibe 150mg,. No mérito, requer a procedência da ação, com confirmação do pedido liminar com a concessão do medicamento. Pugnou pela procedência.

Concedida medida liminar (evento 5, DESPAOFC1).

Citada, a parte demandada apresentou defesa (evento 15, CONT1). Preliminarmente, impugnou o valor da causa. Refutou os argumentos da exordial. Postulou pela improcedência.

Réplica (evento 18, RÉPLICA1).

Oportunizada a produção de provas (evento 20, DESPADEC1).

É o relatório. Decido.

2) Afasto a preliminar de impugnação ao valor da causa, visto que o valor foi corretamente atribuído, conforme preceitua o art. 292, 2º, do CPC.

No mérito, menciona-se o disposto na Súmula 608, do STJ, *in verbis*:

Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Assim, configurada a relação de consumo entre as partes, aplica-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

A parte demandada pugna pela não aplicação da Lei nº. 9.656/98, ao caso concreto, uma vez que a contratação é anterior a promulgação da Lei.

Tal argumento não prospera, visto que se tratam de contratos de trato sucessivo:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. ***PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI 9.656/98.*** *TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM ANTIANGIOGÊNICO. COBERTURA DEVIDA. Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante disposição do artigo 3º, § 2º, bem como pelo que dispõe a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 35 da Lei nº 9.656/1998.* ***Aplica-se a Lei 9.656/98 aos contratos de plano de saúde firmados anteriormente à sua vigência em razão destes serem de trato sucessivo, conforme pontuado em sentença. Noutras palavras, cada renovação conta como se fosse um novo contrato, o qual deve estar em consonância com a legislação aplicável à época.*** *Ademais, cumpre destacar que o regramento do artigo 35 da Lei 9.656/98 (aplicável somente no ínterim entre a vigência da lei em comento e a próxima renovação, considerando a tese anteriormente firmada) exige que as operadoras notifiquem os contratantes a respeito da possibilidade de adaptação, não podendo a sua falta ser interpretada em desfavor do consumidor nos termos do CDC (art. 47). Nesses termos, reconhecida a aplicabilidade da Lei nº 9.656/98 no presente caso. As coberturas de procedimentos médicos por planos de saúde se sujeitam a um rol mínimo editado pela ANS, o qual não pode prever as hipóteses do art. 10 da Lei nº 9.656/98 e não pode excluir ou mitigar as hipóteses do art. 12 da mesma Lei. Não obstante, evidentemente que os contratos firmados podem alargar o espectro mínimo de cobertura, inclusive cobrindo as hipóteses do citado art. 10. Ressalte-se, outrossim, que é facultado aos planos de saúde estabelecerem para quais patologias irão oferecer cobertura; no entanto, não podem limitar o tratamento, pois este cabe somente ao médico assistente do paciente segurado. Nessa senda, tem-se que o tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico postulado, haja vista, sobretudo, a expressa recomendação pelo médico assistente, a ausência de comprovação de oferta à autora de adaptação do plano de saúde aos ditames da Lei nº 9.656/98 e a aplicabilidade da legislação consumerista, é de cobertura obrigatória. Honorários sucumbenciais majorados, em atenção ao preconizado pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70084080480, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 29-04-2020)(Grifou-se)*

APELAÇÃO CÍVEL. ***SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI 9.656/98. FORNECIMENTO DE LENTES INTRAOCULARES. COBERTURA DEVIDA. REEMBOLSO DE VALORES.*** *CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.* ***Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante disposição do artigo 3º, § 2º, bem como pelo que dispõe a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 35 da Lei nº 9.656/1998. Aplica-se a Lei 9.656/98 aos contratos de plano de saúde firmados anteriormente à sua vigência em razão destes serem de trato sucessivo, conforme pontuado em sentença. Noutras palavras, cada renovação conta como se fosse um novo contrato, o qual deve estar em consonância com a legislação aplicável à época.*** *Ademais, cumpre destacar que o regramento do artigo 35 da Lei 9.656/98 (aplicável somente no ínterim entre a vigência da lei em comento e a próxima renovação, considerando a tese anteriormente firmada) exige que as operadoras notifiquem os contratantes a respeito da possibilidade de*

adaptação, não podendo a sua falta ser interpretada em desfavor do consumidor nos termos do CDC (art. 47). Nesses termos, reconhecida a aplicabilidade da Lei nº 9.656/98 no presente caso. As coberturas de procedimentos médicos por planos de saúde se sujeitam a um rol mínimo editado pela ANS, o qual não pode prever as hipóteses do art. 10 da Lei nº 9.656/98 e não pode excluir ou mitigar as hipóteses do art. 12 da mesma Lei. Não obstante, evidentemente que os contratos firmados podem alargar o espectro mínimo de cobertura, inclusive cobrindo as hipóteses do citado art. 10. Nessa senda, tem-se que próteses ligadas ao ato cirúrgico, caso dos autos, nos termos do que dispõe o art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98, não podem ser excluídas da cobertura ofertada pelos planos de saúde. Reconhecendo-se o dever de cobertura, é devida ao demandante a restituição, a título de danos materiais, das despesas com a aquisição das lentes intraoculares utilizadas em procedimento cirúrgico que realizou. De outro lado, inocorrente o dano extrapatrimonial, eis que o descumprimento contratual, por si só, não dá ensejo à indenização por danos morais, não restando comprovada excepcionalidade no sentido de que os direitos da personalidade da parte autora tenham sido afrontados. Sucumbência redistribuída. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70082505512, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 25-09-2019)(Grifou-se)

Assim, aplica-se a Lei nº. 9.656/98 ao caso concreto.

No caso do feito, cumpriria a demandada comprovar que a resposta dada à solicitação da parte autora estaria de acordo com o caso específico, respeitada a regulamentação dos planos pela Lei 9.656/98. É que, na hipótese, impõe-se à requerida o ônus de demonstrar de forma técnica o fundamento da imposição de óbice que, na prática, resulta em negativa de cobertura:

*APELAÇÃO CÍVEL. **PLANO DE SAÚDE**. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPETIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. STENDS. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. REPETIÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Os planos de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual se aplica o disposto no art. 35 da Lei 9.656/98 ao caso em tela, decorrente de interpretação literal e mais benéfica aos aderentes. **2. Ausência de comprovação de oferta ao consumidor para migração às regras previstas pela nova legislação (Lei n. 9.656/98), com uma cobertura mais abrangente. Aplicabilidade da Lei n. 9.656/98 à hipótese dos autos, independentemente de ter havido a adequação do contrato firmado entre as partes a esta legislação. 3. Não há como o plano de assistência à saúde negar cobertura da prótese/órtese utilizada para a realização do procedimento cirúrgico, porque o art. 10 da Lei n° 9.656/98 não exclui da cobertura do contrato de plano de saúde o fornecimento de materiais essenciais à realização de cirurgia. Cabe ao médico definir qual é o melhor tratamento para o segurado bem como qual espécie de material melhor atende à finalidade esperada.** 4. Da mesma forma, sendo necessário exames para diagnóstico da doença, havendo previsão de cobertura para a moléstia, indevida a recusa pela ré. 5. No entanto, não há falar em repetição dos valores de qualquer espécie, uma vez que a autora não pagou os valores e impugna as cobranças. 6. O descumprimento contratual, por si só, não dá ensejo ao reconhecimento de danos extrapatrimoniais. Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia, situação inocorrente nos autos. 7. Em virtude do dever de cobertura integral pela UNIMED, corolário lógico é extinção da reconvenção promovida pelo Hospital, uma vez que a autora é parte ilegítima para responder pelo débito. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70081404691, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-05-2019)(Grifou-se)*

De fato, a alegação de falta de previsão contratual não seria suficiente para afastar a obrigatoriedade da cobertura, posto que assiste ao médico a escolha dos procedimentos que melhor se adapte ao contexto patológico a ser administrado.

Ademais, vigente a proteção contratual a que faz jus o consumidor, nos termos dos arts. 46 e ss. do CDC, há que se interpretar o contrato em benefício do hipossuficiente, a fim de manter um equilíbrio contratual entre as partes. Com efeito, cediço que o contrato é típico de adesão, pelo qual a parte consumidora adere a cláusulas preexistentes sem oportunidade de discussão, deveria ser preservada, em prol do contratante, uma certa previsibilidade para o caso de eventual exclusão de custeio do procedimento desejado.

A falta de previsão no rol da ANS para o tratamento necessitado pela parte autora, não veio ratificada por alguma prova, nem seria capaz de afastar a genérica oferta de cobertura, dada de acordo com o art. 10 da Lei n° 9.656/1998. De fato, o art. 16, § 1º, da Lei dos Planos de Saúde, permite que sejam aportados aos contratos algumas exclusões de cobertura, mas nada indica que exista a indigitada exclusão junto ao contrato de que a parte autora é beneficiária. A normativa da ANS, citada na contestação, estabelece padrões mínimos de atendimento, mas, por si só, não autorizam que a ré negue cobertura, quando não a limitou contratualmente e de forma específica. E, neste contexto, a hipótese de negativa de cobertura, na situação do demandante, estaria fora dos limites de previsibilidade para o consumidor.

Cuida-se de utilização de procedimento mais adequado para a frágil situação da parte autora, indicado pelo médico, a ser aplicado imediatamente para incremento de chances de sucesso para uma paciente. Veja-se, nenhuma forma de interpretação do contrato entabulado poderia excluir da cobertura contratada procedimento específico indicado por médico habilitado pela própria seguradora, para preservação da saúde e vida do paciente.

Ainda, tem-se entendido que incumbe ao médico e não à seguradora a projeção de indicações técnicas relacionadas ao tratamento, que alterem a obrigatoriedade genérica da RN 387 da ANS. Portanto, descabe a seguradora brandeie critérios próprios e, desconhecidos ao consumidor, para fins de estilar negativas de cobertura, sem algum lastro contratual válido:

*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM SINDROME DE DOWN. TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES DE TRATAMENTO. DESCABIMENTO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS RECURSAIS. I. No caso em tela, o autor, menor de idade, foi diagnosticado com Síndrome de Down (CID10 Q90.9), necessitando de atendimento interdisciplinar no conceito nervoevolutivo Bobath, com fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia, psicoterapia, neurologia infantil, neuro-oftalmologia, geneticista, equoterapia, hidroterapia, além de outras abordagens terapêuticas, como protocolo PediaSuit. Por sua vez, a operadora defendeu a legalidade da limitação das sessões de fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia, bem como da negativa de cobertura aos demais tratamentos, sob a alegação de que não há previsão de cobertura no plano de saúde contratado. II. Entretanto, os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula 608, do STJ, devendo ser interpretados de maneira mais favorável à parte mais fraca nesta relação. **De outro lado, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito ou o número de sessões, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Além do mais, deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual. Incidência dos arts. 47 e 51, IV, § 1°, II, do CDC. III.** Com efeito, os referidos tratamentos não estão previstos nas hipóteses de exclusão do art. 10, da Lei nº 9.656/98, a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à **saúde**. Ademais, descabida à negativa de*

autorização para realização do procedimento exclusivamente em razão de o profissional solicitante não pertencer à rede própria ou credenciada da operadora, nos termos do art. 2º, VI, da Resolução nº 08/98. IV. Por fim, e mais importante, vale dizer que está em jogo a saúde, a qualidade de vida e o desenvolvimento de uma criança de quatorze anos de idade, ou seja, deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual. V. Portanto, impõe-se à operadora do plano suportar integralmente as despesas dos tratamentos em questão, da forma como determinado na sentença. VI. Manutenção dos honorários advocatícios do procurador do autor, uma vez que observados os limites do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, bem como compatíveis com aqueles arbitrados por esta Câmara em casos similares. VII. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÕES DESPROVIDAS.(Apelação Cível, Nº 70079977450, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 27-03-2019).(Grifou-se)

Além disso, o plano de saúde não pode deixar de alcançar ao segurado a cobertura de tratamento imprescindível para manutenção da sua saúde, mesmo que isto implique em algum custo a mais. Saliente-se que devem prevalecer o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e o inalienável direito à vida, face à análise de custo e risco realizada pela seguradora, que não pode negar cobertura de modo arbitrário:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA DE COBERTURA DAS TERAPIAS INDICADAS PARA O TRATAMENTO. DESCABIMENTO. Trata-se de ação de obrigação de fazer, através da qual a parte autora postula cobertura das terapias indicadas pelo médico para o tratamento do autismo, julgada procedente na origem. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de seguro, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3º, §2º do CDC e inteligência da Súmula 608 do STJ. Verifica-se que a parte autora foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID10-F84), sendo indicadas diversas terapias como terapia ocupacional, musicoterapia, fonoaudiologia, psicoterapia, terapia Teacch, e psicomotricidade (fls. 95/102), sendo que foram negadas pela requerida, com base no rol da ANS. Vislumbra-se que não há cláusula contratual prevendo expressamente a exclusão de cobertura das terapias postuladas pelo autor, assim, não se pode limitar os direitos conferidos ao segurado em virtude do contrato, sob o argumento de que a Resolução da ANS não o prevê. ***Tendo em vista que a moléstia que acomete o autor não está inclusa no rol de exceções do artigo 10 da Lei nº. 9.656/98, é de ser mantida a sentença que julgou procedente a ação determinado que o tratamento deve ser concedido nos moldes pleiteados na exordial.*** *APELAÇÃO DESPROVIDA(Apelação Cível, Nº 70080997455, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 27-06-2019)(Grifou-se)*

Apelação civil. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Autora portadora de paralisia cerebral. Pedido de cobertura de tratamento multidisciplinar com sessões de fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, atendimento psicoterápico; musicoterapia, equoterapia, tratamento com neurologista, protocolos pediasuit, fornecimento de andador pacer, neuropediatra especializada em moléstias neurológicas e ortopedista. Dever de cobertura reconhecido quanto às terapias efetivamente prescritas para proporcionar desenvolvimento e qualidade de vida à autora. A ausência de previsão no rol da ANS ou o desatendimento de diretrizes expedidas pela agência, por si só, não afastam o dever de cobertura. Manutenção da sentença quanto ao indeferimento de musicoterapia e equoterapia diante da inexistência de prescrição médica. A prestação das coberturas deferidas deve dar-se preferencialmente dentro da rede credenciada. ***No caso de inexistência de prestador dentro da rede credenciada caberá ao plano indicar prestador fora da rede, nos termos do disposto no art. 4º da RN 259 da ANS, apenas diante da ausência de indicação de profissional as terapias devem ser custeadas fora da rede credenciada. Manutenção da sentença quanto ao afastamento do pedido de realização das terapias em ambiente domiciliar.*** *Correto o arbitramento dos honorários por equidade, tendo em vista a impossibilidade de mensuração do proveito econômico obtido. Pedido de majoração da verba honorária rejeitado. Apelos não providos.(Apelação Cível, Nº 70081693624, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 29-08-2019).(Grifou-se)*

Assim, deve a parte demandada promover a cobertura do medicamento Nintedanibe 150mg (evento 18, NOTATEC2 e evento 18, NOTATEC3).

Nesse sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NINTEDANIBE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. ROL DA ANS. COBERTURA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. I. NO PRESENTE CASO, A AUTORA PRETENDE VER RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM COBRIR OS CUSTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO NINTEDANIBE (OFEV) - 150 MG, EM RAZÃO DE QUADRO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (CID 10 J84.1). II. O CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE ESTÁ SUBMETIDO ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESTAS CIRCUNSTÂNCIAS, O ART. 47, DO CDC, DETERMINA QUE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SERÃO INTERPRETADAS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. IGUALMENTE, DEVE INCIDIR O DISPOSTO NO ART. 51, IV, § 1°, II, DO CDC, SEGUNDO O QUAL É NULA A CLÁUSULA QUE ESTABELEÇA OBRIGAÇÕES CONSIDERADAS INÍQUAS, QUE COLOQUEM O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM. III. É LÍCITA A EXCLUSÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR, ISTO É, AQUELES PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE PARA ADMINISTRAÇÃO EM AMBIENTE EXTERNO AO DA UNIDADE DE SAÚDE, SALVO OS ANTINEOPLÁSICOS ORAIS E CORRELACIONADOS, A MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) E OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM, NA FORMA DOS ARTS. 10, VI, E 12, I, "C", E II, "G", DA LEI N° 9.656/98. PRECEDENTES DO STJ. IV. CONFORME SE EXTRAI DA BULA DO MEDICAMENTO OFEV (NINTEDANIBE), O FÁRMACO EM QUESTÃO É INDICADO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE PULMÃO, ESTANDO INCLUÍDO NA CATEGORIA DE ANTINEOPLÁSICOS, TENDO SIDO INSERIDO NO ROL DA ANS ATRAVÉS DA RN Nº 465/2021 QUE DISPÕE SOBRE O ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE NO ÂMBITO DA SAÚDE SUPLEMENTAR. V. APESAR DE O MEDICAMENTO TER SIDO INSERIDO NO ROL DA ANS QUANDO INDICADO AO TRATAMENTO DE PACIENTES COM CÂNCER DE PULMÃO, A EXISTÊNCIA DE DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO NÃO AFASTA O DEVER DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE, PORQUANTO OS PLANOS DE SAÚDE APENAS PODEM ESTABELECER PARA QUAIS DOENÇAS OFERECERÃO COBERTURA, NÃO LHES CABENDO LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ PRESCRITO, INCUMBÊNCIA ESSA QUE PERTENCE AO PROFISSIONAL DA MEDICINA QUE ASSISTE O PACIENTE. VI. TAMBÉM, É POSSÍVEL COBERTURA DE PROCEDIMENTO OU TRATAMENTO QUE NÃO ESTEJA PREVISTO NO ROL DA ANS QUANDO EXISTIR COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA, À LUZ DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE, BASEADA EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E PLANO TERAPÊUTICO, OU RECOMENDAÇÃO PELA COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (CONITEC), OU DE, NO MÍNIMO, 1 (UM) ÓRGÃO DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE QUE TENHA RENOME INTERNACIONAL, DESDE QUE SEJAM APROVADAS TAMBÉM PARA SEUS NACIONAIS. VII. NO CASO, HÁ NOTA TÉCNICA DA PLATAFORMA E-NATJUS (NOTA TÉCNICA 146392) FAVORÁVEL À REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO COM O USO DO MEDICAMENTO ESILATO DE ***NINTEDANIBE EM PACIENTE PORTADOR DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA, COMO É O CASO DA AUTORA. VIII. PORTANTO, À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI N° 9.656/98, IMPÕE-SE À OPERADORA DO PLANO SUPORTAR AS DESPESAS DO TRATAMENTO EM QUESTÃO.*** *APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50042000720228210010, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 26-07-2023)(Grifou-se)*

3) Ante o exposto, rejeito a prefacial, no mérito JULGO PROCEDENTE a ação. Confirmo a medida liminar reconhecendo à parte autora o direito a cobertura do medicamento Nintedanibe 150mg, nos moldes da exordial, bem como diante do diagnóstico médico apresentado (evento 1, OUT8).

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, em 10% sobre o valor atualizado da causa, com correção monetária conforme a variação do IPCA[1] desde a data da sentença e juros de mora de 12% ao ano desde a data do trânsito em julgado da decisão.

Com o trânsito em julgado, apuradas eventuais custas, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE SCHWARTZ MANICA, Juiz de Direito**, em 18/10/2023, às 15:24:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10048180407v5** e o código CRC **2e01813b**.

---

1. Provimento Nº 014/2022-CGJ - Altera a redação do artigo nº 507 da Consolidação Normativa Judicial para a utilização do IPCA."Art. 507 – O Contador deverá utilizar o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) quando não houver definição judicial no processo quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado na realização do cálculo, se outro não estiver previamente definido na legislação." ↩